

Vruchtbaarheid, anticonceptie en kinderwens

De methoden om zwangerschap te voorkomen, en wat er mogelijk is als een zwangerschap uitblijft.

1 Natuurlijke methoden

Drie methoden zijn natuurlijk, dus **zonder middel of ingreep**: de **kalendermethode**, de **temperatuurmethode** en de **ovulatiemethode**.

De **kalendermethode** berust op het schatten van de vruchtbare dagen uit **vorige cycli**. Bij de **temperatuurmethode** merk je dat de **temperatuur licht stijgt na de eisprong**. De methode waarbij je **het slijm van de baarmoederhals bekijkt om de eisprong te herkennen**, heet de **ovulatiemethode** of **billingsmethode**.

Coïtus interruptus is géén betrouwbare methode om zwangerschap te voorkomen. Er komen al zaadcellen vrij voor de zaadlozing, en het hangt volledig af van het juiste moment.

2 Hormonale methoden

Drie middelen werken met hormonen: de **combinatiepil**, het **hormoonstaafje** en de **vaginale ring**. De **combinatiepil voorkomt een zwangerschap doordat ze de eisprong tegenhoudt**.

Het verschil tussen de minipil en de combinatiepil is dat de minipil maar één soort hormoon bevat. Een **hormoonstaafje in de arm werkt enkele jaren**, en een **prikpil werkt ongeveer drie maanden**.

De **morning-afterpil** is de pil die je **ná onbeschermd vrijen inneemt om een zwangerschap nog te voorkomen**. Ze heet ook **noodanticonceptie**, en ze werkt beter hoe sneller je ze neemt.

Niet alle anticonceptiemiddelen werken met hormonen: er bestaat ook een **spiraaltje zónder**. Daarin zit het metaal **koper**, en dat **maakt zaadcellen onbeweeglijk**.

3 Barrièremethoden en sterilisatie

Drie methoden zijn barrièremethoden, die **de zaadcellen mechanisch tegenhouden**: het **mannencondoom**, het **vrouwencondoom** en het **pessarium of diafragma**.

Van al die methoden beschermen er **twee ook tegen soa's**: het **mannencondoom** en het **vrouwencondoom**. **Wie de pil neemt, heeft daarnaast dus wél bescherming tegen soa's nodig**, want de pil houdt geen enkele infectie tegen.

Een **zaaddodend middel gebruik je het best samen met een barrièremethode**; alleen is het te onzeker.

Sterilisatie is de betrouwbaarste methode. Bij een sterilisatie bij de man worden de zaadleiters onderbroken, bij de vrouw de eileiters. Je gaat er het best van uit dat het blijvend is.

De betrouwbaarheid is in de praktijk vaak lager dan op papier, omdat een methode verkeerd of onregelmatig gebruikt wordt. En anticonceptie is een keuze die bij de persoon zelf past, omdat gezondheid, leeftijd en levensritme per persoon verschillen.

4 Als een zwangerschap uitblijft

Men spreekt van **onvruchtbaarheid als er na een jaar onbeschermd vrijen geen zwangerschap is. Onvruchtbaarheid ligt ongeveer even vaak bij de man als bij de vrouw**, en soms bij beiden samen of bij geen van de twee duidelijk.

Bij de man onderzoekt men eerst het sperma, op aantal en beweeglijkheid. Dat is een eenvoudig onderzoek en het sluit meteen veel uit.

De **menopauze** is het moment **waarop de eierstokken stoppen met werken en de menstruatie wegblijft**. Ze heet ook de overgang.

5 Behandelingen bij een kinderwens

Hormonale stimulatie heeft als doel **de eierstok aan te zetten om eicellen te laten rijpen**. Omdat er dan meerdere eicellen rijpen, **verhoogt hormonale stimulatie de kans op een meerling**.

Bij **kunstmatige inseminatie of KI** wordt **sperma rechtstreeks in de baarmoeder gebracht**. De afkorting **IVF** staat voor **in vitro fertilisatie** of in-vitrofertilisatie: de bevruchting gebeurt buiten het lichaam, in het labo. **Het verschil met ICSI is dat bij ICSI één zaadcel in de eikel geprikt wordt**, terwijl bij gewone IVF de zaadcellen zelf de eikel moeten binnendringen.

Bij IVF groeit de vrucht niet de hele zwangerschap in het labo. Na enkele dagen wordt het embryo in de baarmoeder geplaatst, en daar verloopt de zwangerschap verder zoals altijd. **Men haalt vaak meerdere eicellen, omdat niet elke eikel bevrucht raakt of goed doorgroeit**.

Eicellen of sperma invriezen heeft als doel **de vruchtbaarheid te bewaren voor later**, bijvoorbeeld voor een behandeling die ze kan aantasten.

6 Wat de vruchtbaarheid aantast

Drie gewoonten verlagen de vruchtbaarheid bij **man én vrouw: roken, veel alcohol drinken en drugsgebruik. Wie met een kinderwens rookt, stopt dus het best vóór de zwangerschap en niet pas als ze er is:** zaadcellen en eicellen rijpen maanden vooraf.

De leeftijd van de vrouw verlaagt de kans op zwangerschap doordat de voorraad eicellen daalt en hun kwaliteit afneemt. Ook het gewicht speelt mee, en **niet alleen overgewicht kan de cyclus verstoren: ondergewicht evengoed.**

Warmte is slecht voor de aanmaak van zaadcellen, omdat zaadcellen het best rijpen net onder de lichaamstemperatuur. Daarom hangen de teelballen buiten het lichaam.

Chemotherapie en bestraling of radiotherapie zijn behandelingen tegen kanker die **de vruchtbaarheid blijvend kunnen aantasten.** Daarom wordt invriezen soms vooraf voorgesteld.

Twee invloeden van buitenaf kunnen de vruchtbaarheid aantasten: **zware metalen zoals lood en cadmium en langdurige, zware stress.** En **een soa die niet behandeld wordt, kan tot onvruchtbaarheid leiden,** doordat de eileiders of de zaadleiders beschadigd raken.

Onthoud dit

- Kalender-, temperatuur- en ovulatiemethode zijn de natuurlijke methoden.
- De combinatiepil houdt de eisprong tegen; een koperspiraal werkt zonder hormonen.
- Alleen het mannen- en het vrouwencondoom beschermen ook tegen soa's.
- Sterilisatie is het betrouwbaarst, coïtus interruptus het onzekerst.
- Onvruchtbaarheid: na een jaar onbeschermd vrijen geen zwangerschap.
- Bij IVF gebeurt de bevruchting in het labo, de zwangerschap in de baarmoeder.
- Bij ICSI wordt één zaadcel in de eicel geprikt.
- Roken, alcohol, drugs, leeftijd, gewicht, warmte en stress verlagen de vruchtbaarheid.

